Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:31
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:32
Temps mis	49 s
Points	4,20/19,00
Note	**4,42** sur 20,00 (**22,11**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les diurétiques de l'anse, quel(s) est(sont) leur(s) effet(s) parmi les suivants ?

- a. Ils provoquent une calciurie importante. ✔
- b. Ils provoquent une natriurèse importante. ✔
- c. Ils provoquent une acidose métabolique. ✖
- d. Ils provoquent une hyperkaliémie. ✖
- e. Ils provoquent parfois une gynécomastie. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Ils provoquent une calciurie importante., Ils provoquent une natriurèse importante.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Vous suivez un patient, de 70 ans, qui a présenté il y a 5 ans une vascularite à ANCA avec des Anti-PR3 au diagnostic positif à 1200 Ui/mL (normale < 20).

Il avait été traité par RITUXIMAB 4 injections à l'induction puis un entretien tous les 6 mois par RITUXIMAB.

Une biopsie avait été réalisée il y a 1 an devant la persistance d'une insuffisance rénale chronique avec une créatinine à 130 micromol/l et une protéinurie à 80mg/mmol. Celle-ci n'avait retrouvé que des lésions chroniques avec quelques lésions de hyalinose segmentaire et focale. Il n'y avait pas d'argument pour une activité de la maladie. Les derniers ac anti-PR3 étaient négatifs. L'entretien par Rituximab a donc a été interrompu.

Vous recevez son bilan trimestriel qui retrouve une créatinine à 400 micromol/l sans trouble ionique. Le bilan urinaire retrouve une protéinurie à 90 mg/mmol avec absence d'hématurie ou leucocyturie. Vous l'appelez et il se plaint de douleurs hypogastriques et dysurie.

Quel examen devez vous réaliser en urgence (1 seule réponse) ?

- a. Un scanner abdominopelvien avec injection de produit de contraste
- b. Une scintigraphie rénale ✖
- c. Une échographie réno-vésicale
- d. Une biopsie rénale s'il ne présente pas de contre indication.
- e. Des hémocultures

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Une échographie réno-vésicale

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Un patient, de 35 ans, consulte pour des épisodes d'hématuries répétés. Il ne présente pas d'antécédent et ne prend pas de traitement. Ces épisodes surviennent sans facteurs déclenchant identifiés et sont résolutifs spontanément. Vous souhaitez confirmer le diagnostic d'hématurie. Quel examen réalisez vous (1 seule réponse) ?

- a. Une bandelette urinaire
- b. Un dosage de la protéinurie avec calcul du rapport protéinurie/Créatininurie ✖
- c. Un dosage de la créatinine sanguine
- d. Un examen cytobactériologique des urines
- e. Un test à l'eau Oxygéné

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Un examen cytobactériologique des urines

---

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Un patient, de 65 ans, se présente à votre cabinet pour suivi de son diabète de type 2. Celui-ci est connu depuis 10 ans et est compliqué de rétinopathie diabétique. Il a par ailleurs de l'hypertension.

Il prend comme traitement:

- Metformine 750 mg x 2 par jour (antidiabétique oral)
- Ramipril 10mg/jour (IEC à dose maximale)

Il vous ramène son bilan qui retrouve:

- HbA1C à 6,9%
- NFS normale
- Créatinine: 70 micromol/l avec un DFG à 96mL/min
- Ionogramme normal

Le bilan urinaire retrouve un rapport Albuminurie/Créatininurie à 40mg/mmol sans hématurie ni leucocyturie associé.

Quelle classe médicamenteuse ajoutez vous à son traitement (1 seule réponse) ?

- a. Aspirine
- b. Gliflozine ✔
- c. Antagoniste du récepteur à l'angiotensine 2
- d. Diurétiques du tube collecteur
- e. Il n'y a pas d'indication à rajouter un autre traitement

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Gliflozine

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Vous recevez un patient, de 67 ans, diabétique depuis 20 ans. Dans le cadre de son diabète, vous prescrivez une analyse urinaire pour rechercher une atteinte rénale de son diabète.

Vous récupérez les résultats :

- Na U : 65mmol/l
- K U : 25mmol/l
- Urée : 200mmol/l
- Albuminurie 25mg/l
- Créatininurie : 5mmol/l

Quelle est la proposition juste concernant l'atteinte rénale (1 seule réponse) ?

- a. Il existe une Albuminurie A1.
- b. Il existe une Albuminurie A2. ✔
- c. Il existe une Albuminurie A3.
- d. Il existe une Albuminurie A4.
- e. Il n'y a pas d'atteinte rénale.

La réponse est correcte.

La réponse correcte est : Il existe une Albuminurie A2.

Question 6

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Vous récupérez les résultats d'une biopsie rénale faite chez une patiente de 50 ans pour l'exploration d'un syndrome néphrotique. La patiente ne prend pas de traitement particulier hormis des AINS pour des céphalées et n'a pas d'antécédent. La biopsie retrouve une Glomérulonéphrite extra membraneuse Ac anti-PLA2R négative.

Parmi ces propositions, quelles sont les 3 réponses exactes (QRP) ?

— 3 réponses sont attendues —

- a. Il peut s'agir d'une GEM secondaire à une maladie auto-immune de type Lupus. ✔
- b. L'atteinte peut être satellite d'un cancer mammaire. ✔
- c. L'atteinte peut être secondaire à la prise d'AINS. ✔
- d. L'atteinte peut être secondaire à une néphropathie à IgA.
- e. Cette atteinte doit faire rechercher une atteinte pulmonaire (syndrome pneumo-rénal).

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Il peut s'agir d'une GEM secondaire à une maladie auto-immune de type Lupus., L'atteinte peut être satellite d'un cancer mammaire., L'atteinte peut être secondaire à la prise d'AINS.

Question 7

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les critères suivants, le(s)quel(s) permet(tent) de différencier une insuffisance rénale aigue d'une insuffisance rénale chronique ?

- a. Hémoglobinémie ✔
- b. Intensité de l'insuffisance rénale ✖
- c. Taille des reins ✔
- d. Présence d'une hyperparathyroïdie ✖
- e. Absence d'hématurie ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Hémoglobinémie, Taille des reins

---

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Situation clinique:

- Homme de 65 ans, sous inhibiteur de l'enzyme de conversion pour une hypertension artérielle
- Diarrhées et vomissements profus pendant 5 jours
- A perdu 5 kg
- TA: 80/50 mmHg
- FC: 98 bpm
- Créatinine: 500 µmol/l
- Urée: 25 mmol/l
- Kaliémie: 4,2 mmol/l
- Echographie rénale sans particularité
- Na U: 35 mmol/l
- K U: 25 mmol/l
- Protéinurie: 0,8 g/l
- Albuminurie: 0,1 g/l
- Hématies: 8/mm^3
- Leucocytes: 5/mm^3

Quel est le diagnostic le plus probable (1 seule réponse) ?

- a. Insuffisance rénale aigue par emboles de cristaux de cholestérol
- b. Insuffisance rénale aigue sur poussée de Néphropathie à IgA ✖
- c. Insuffisance rénale aigue par nécrose tubulaire aigue
- d. Insuffisance rénale aigue par néphrite immuno-allergique
- e. Insuffisance rénale aigue par syndrome néphritique aigue

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Insuffisance rénale aigue par nécrose tubulaire aigue

---

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Cas clinique:

- Femme de 70 ans, suivie pour une hypertension artérielle, diabète, deux accidents vasculaires cérébraux, une dyslipidémie, une artérite oblitérante des membres inférieurs.
- Elle a bénéficié d'une coronarographie diagnostique 15 jours auparavant.
- Elle est à 170/95 mmHg, FC 80 bpm Apyrétique. Apparition récente d'un livedo
- Créatininémie: 350 µmol/l
- Bandelette urinaire : Protéinurie 1 + Hématurie 1+ Leucocyturie –
- Echographie rénale normale

Quel est le diagnostic le plus probable (1 seule réponse) ?

- a. Insuffisance rénale aigue par emboles de cristaux de cholestérol
- b. Insuffisance rénale aigue sur poussée de Néphropathie à IgA ✖
- c. Insuffisance rénale aigue par nécrose tubulaire aigue
- d. Insuffisance rénale aigue par néphrite immuno-allergique
- e. Insuffisance rénale aigue par syndrome néphritique aigue

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Insuffisance rénale aigue par emboles de cristaux de cholestérol

---

Question 10

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les complications de la maladie rénale chronique dans les stades les plus avancés. Quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) exacte(s) ?

- a. La première cause de mortalité du patient insuffisant rénale chronique est l'hyperkaliémie. ✖
- b. L'hypocalcémie est fréquente du fait d'une hypoparathyroïdie. ✖
- c. L'hypophosphatémie est fréquente du fait de l'hyperparathyroïdie secondaire. ✖
- d. Un régime pauvre en calcium est nécessaire. ✖
- e. Un régime pauvre en phosphore est nécessaire. ✔

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Un régime pauvre en phosphore est nécessaire.

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant l'anémie du patient insuffisant rénal chronique, quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) correcte(s) ?

- a. Elle est le plus souvent normochrome normocytaire arégénérative. ✔
- b. Elle s'accompagne le plus souvent d'hémolyse mécanique. ✖
- c. Les objectifs biologiques concernant le stock martial chez le patient insuffisant rénal est plus bas que la population générale pour éviter la surcharge en fer. ✖
- d. Le recours à la transfusion doit être favorisé chez le patient insuffisant rénal en raison de son risque cardiovasculaire. ✖
- e. Un traitement par érythropoïétine injectable est envisageable pour corriger l'anémie. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Elle est le plus souvent normochrome normocytaire arégénérative., Un traitement par érythropoïétine injectable est envisageable pour corriger l'anémie.

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Vous suivez un patient, de 50 ans, pour une maladie rénale chronique diabétique avec un DFG à 40 ml/min. Il est père de 3 enfants, cadre dans la fonction publique. Il pratique le tennis de façon occasionnelle, il est droitier.

Quelle(s) est(sont) la(les) mesure(s) à mettre en place ?

- a. Contrôle tensionnel avec un IEC ✔
- b. Vaccination contre l'hépatite B ✔
- c. Réaliser les prises de sang sur le membre supérieur droit ✔
- d. Inscription sur liste de greffe ✖
- e. Création de la voie d'abord pour dialyse de type Fistule artérioveineuse ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Contrôle tensionnel avec un IEC, Vaccination contre l'hépatite B, Réaliser les prises de sang sur le membre supérieur droit

---

Question 13

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Vous recevez en consultation, monsieur P, âgé de 54 ans, que vous suivez pour une PKRAD lié à un variant pathogène documenté situé sur le gène PKD1. Il a amené son épouse et ses 3 enfants : Léa 19 ans, Karim 16 ans, et Thimoté 14 ans car il s'inquiète de leur avoir transmis sa maladie.

Quelles informations pouvez-vous lui donner ?

- a. Le risque de transmission de la maladie à ses enfants est de 50% par enfant. ✔
- b. Si Léa présente trois kystes rénaux à droite et aucun à gauche, on peut affirmer qu'elle est atteinte de PKRAD. ✔
- c. Si Léa n'a pas de kyste à l'échographie, on peut exclure chez elle le diagnostic de PKRAD. ✖
- d. Seuls ses garçons sont potentiellement atteints. ✖
- e. Il faut faire un test génétique à tous ses enfants. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Le risque de transmission de la maladie à ses enfants est de 50% par enfant., Si Léa présente trois kystes rénaux à droite et aucun à gauche, on peut affirmer qu'elle est atteinte de PKRAD.

Question 14

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Vous prenez en charge un patient pour hypercalcémie à 2,95 mmol/l. Vous notez une Parathormone à 3 fois la normale.

Quel(s) est(sont) le(les) diagnostic(s) possible(s) ?

- a. Hyperparathyroïdie primaire ✔
- b. Hyperparathyroïdie secondaire ✖
- c. Sarcoïdose ✖
- d. Hypercalcémie d'immobilisation ✖
- e. Mutation activatrice de CaSR (Calcium Sensor Receptor) ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Hyperparathyroïdie primaire, Mutation activatrice de CaSR (Calcium Sensor Receptor)

Question 15

Partiellement correct

Note de 0,60 sur 1,00

Vous prenez en charge une patiente qui vous est adressée pour hypocalcémie à 2,05 mmol/l.

Quels sont les 5 examens complémentaires utiles en première intention ?

— 5 réponses sont attendues —

- [x] a. Calcémie ionisée ✔
- [x] b. Phosphate sérique ✔
- [x] c. Magnésémie ✖
- [x] d. Electrophorèse des protéines sériques ✖
- [x] e. 25 OH Vitamine D ✔
- [ ] f. Parathormone (PTH) plasmatique
- [ ] g. Parathormone (PTH) urinaire
- [ ] h. Calciurie des 24h
- [ ] i. Phosphaturie des 24h
- [ ] j. Ostéodensitométrie
- [ ] k. Scintigraphie osseuse

Vous en avez sélectionné correctement 3.
Les réponses correctes sont : Calcémie ionisée, Phosphate sérique, 25 OH Vitamine D, Parathormone (PTH) plasmatique, Calciurie des 24h

---

Question 16

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Vous êtes amené à prendre en charge une patiente avec une kaliémie à 2,5 mmol/l. Parmi les propositions suivantes, la(les)quelle(s) respecte(nt) les règles de bonne prescription de potassium ?

- [x] a. 2g de chlorure de potassium dans 50 cl de G5% en 2h sur voie veineuse périphérique ✖
- [x] b. 2g de chlorure de potassium dans 500 ml de NaCl 0,9% en 2h sur voie veineuse périphérique ✔
- [x] c. 4g de chlorure de potassium dans 250 ml de Ringer Lactate en 4h sur voie veineuse périphérique ✖
- [x] d. 3g de chlorure de potassium dans 75 cl de G5% en 1h sur voie veineuse centrale ✖
- [x] e. Aucune de ces propositions ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : 2g de chlorure de potassium dans 500 ml de NaCl 0,9% en 2h sur voie veineuse périphérique

---

Question 17

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les situations suivantes, quelles sont celles évocatrices d'une sténose athéromateuse des artères rénales ?

- a. Syndrome néphrotique explosif chez un enfant de 8 ans sans antécédent ✖
- b. Hématuries macroscopiques récidivantes chez un homme de 30 ans dans des contextes d'infection ORL ✖
- c. OAP flash chez un homme de 60 ans, polyvasculaire ✔
- d. Dégradation de fonction rénale importante après introduction de RAMIPRIL (IEC) chez une femme de 75 ans coronarienne ✔
- e. Asymétrie de la taille des reins chez un homme de 55 ans, fumeur ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : OAP flash chez un homme de 60 ans, polyvasculaire, Dégradation de fonction rénale importante après introduction de RAMIPRIL (IEC) chez une femme de 75 ans coronarienne, Asymétrie de la taille des reins chez un homme de 55 ans, fumeur

---

Question 18

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la glomérulopathie à lésions glomérulaires minimes, quelle(s) est(sont) la(les) affirmation(s) exacte(s) ?

- a. Elle est la principale cause de syndrome néphrotique chez l'enfant. ✔
- b. Son diagnostic ne peut-être affirmé qu'avec une biopsie rénale. ✖
- c. Elle est responsable d'un syndrome néphrotique d'apparition brutale. ✔
- d. Le syndrome néphrotique est impur dans 40% des cas. ✖
- e. Dans la majorité des cas, la corticothérapie permet d'obtenir une rémission. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle est la principale cause de syndrome néphrotique chez l'enfant., Elle est responsable d'un syndrome néphrotique d'apparition brutale., Dans la majorité des cas, la corticothérapie permet d'obtenir une rémission.

Question 19

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant le syndrome de microangiopathie thrombotique (MAT), quelle(s) est(sont) la(les) réponse(s) exacte(s) ?

- a. Il répond à une définition biologique associant une anémie hémolytique et un thrombopénie auto immune. ✖
- b. L'haptoglobine et les LDH y sont souvent très augmentés. ✖
- c. Sur le plan histologique, on peut remarquer une altération de l'endothélium des capillaires glomérulaires et une impression d'obstruction des lumières capillaires. ✔
- d. Les causes de MAT sont exclusivement les maladies dysimmunitaires. ✖
- e. Le syndrome de Moschowitz (purpura thrombotique thrombocytopénique) caractérisé par une atteinte cérébrale au premier plan, touche préférentiellement les adultes. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Sur le plan histologique, on peut remarquer une altération de l'endothélium des capillaires glomérulaires et une impression d'obstruction des lumières capillaires., Le syndrome de Moschowitz (purpura thrombotique thrombocytopénique) caractérisé par une atteinte cérébrale au premier plan, touche préférentiellement les adultes.